

DFGSO2 / Dentaire 2A	UE	n°
----------------------	----	----



DFGSO2 – BORDEAUX

RONÉOS 2025/2026



Enseignant :	Date et horaire : cours en ligne
Ronéistes : Dr. O.KEROUREDAN	Référents :
• Jade Marquis Dumont • Floriane Yapi	• Bouridane Nour • Boukhatmi Faiza

UE DENTISTERIE RESTAURATRICE

Titre du cours: Consultation et diagnostic en DRE

PLAN :

I. La Consultation

- A. Les points clés
- B. Le déroulement de la consultation
 - 1. Interrogatoire
 - 2. Examen Exo buccal
 - 3. Examen endo-buccal
 - 4. Examens complémentaires
- C. Deux types de consultations
 - 1. Consultation d'urgence
 - 2. Consultation initiale
 - 3. Exemple d'un examen clinique standard

II. Le diagnostic

- A. Les pathologies pulpaire
 - 1. Pulpite réversible
 - 2. Pulpite irréversible symptomatique
 - 3. Pulpite hyperplasique
 - 4. Dégénérescence calcique
 - 5. Résorption interne
 - 6. Nécrose pulpaire
- B. Pathologies péri-apicales
 - 1. Conditions péri-apicales « normales »
 - 2. Parodontite apicale symptomatique ou aiguë (PAA)
 - 3. Parodontite apicale asymptomatique/ Chronique
 - 4. Ostéite condensante
 - 5. Abscès apical aigu (AAA)
 - 6. Abscès apical chronique
 - 7. Kyste péri-apical
 - 8. Cellulite

Objectif de cet enseignement:

- Savoir structurer une démarche de recueil d'information comportant sémiologie, examen clinique, examens radiographiques et autres examens complémentaires
- Savoir poser un diagnostic

Le diagnostic est essentiel alors que ce n'est jamais quelque chose de très facile.

I. LA CONSULTATION

A. Les points clés

Les patients viennent consulter pour **des motifs de consultation très différents**.

- Urgences douloureuses
- Traumatismes (consultation pas prévue à la base : ex : sont tombés et se sont fracturés les dents)
- Phénomènes infectieux (abcès, cellulites maxillo-faciale)
- Gêne fonctionnelle (difficulté à la mastication)
- Esthétique (dyschromies dentaires qui peuvent être traitées par éclaircissement, ...)
- Visite de contrôle
- Réévaluation des facteurs de risques (maladie carieuse, lésion érosive, dysfonctions, ...)

Au niveau de la consultation : il faut donner **toutes les informations au patient**. Le but de la consultation va être de recueillir tous les éléments, de poser un diagnostic et d'élaborer un plan de traitement. Pour que le patient puisse accepter le plan de traitement il faut qu'il ait toutes les informations (en terme de diagnostic, d'options thérapeutique possibles) pour qu'il puisse s'engager dans un traitement. On parle de recueil de **consentement éclairé**.

Il faut proposer différentes options thérapeutiques que ce soit en faisant varier la durée du traitement, le financement/ le coût du traitement, si oui ou non il est nécessaire de faire une réévaluation/ certain traitement nécessite un suivi tous les 3mois, 6mois...

Sans oublier d'informer le patient en amont des aléas thérapeutiques possibles.

La prise en charge de l'urgence est prioritaire

Exemple : un patient consulte pour une douleur sur une dent en bas à droite, lors de la consultation vous remarquez la présence d'une dent fracturée, cariée, infectée. Le but va être de soulager le patient en répondant au motif de consultation.

=> Il faut commencer par traiter l'urgence qui est aussi le motif douloureux. On traite la douleur et ensuite on s'engagera dans un bilan complet, un plan de traitement pour soigner le reste.

Dans tous les cas, **l'urgence passe en priorité**.

Importance du remplissage du dossier médical.

C'est important déjà du point de vue médico-légal, **en cas de conflit** avec un patient. Si un patient revient en urgence il sera possible de **voir ce qui aurait été fait lors de sa dernière consultation**, d'envisager un autre diagnostic par exemple. Cela permet **un gain de temps** pendant les consultations.

S'il est pris en charge par un associé/ collègue il pourra avoir accès à ce dossier, ses antécédents ,sans trop d'efforts.

B. Le déroulement de la consultation

Peu importe la discipline le déroulement reste toujours le même :

1. Interrogatoire :

- En commençant par demander **le motif de consultation**

Pourquoi est-ce que le patient vient nous voir ? (écoute ++ => adaptation de l'examen clinique en fonction du motif pour répondre à la demande du patient)

- **Anamnèse médicale** = recueillir tous les antécédents médicaux (anciennes pathologies), les antécédents chirurgicaux (bien passé ? les complications ?), les allergies, les traitements médicamenteux (on a déjà vu comment certains médicaments ont des conséquences sur la santé bucco-dentaire à prendre en considération). Certains médicaments impactent ++ la santé bucco-dentaire notamment **les anticoagulants qui entraînent des complications suites à des actes dentaires/chirurgicaux**. Il faut donc les prendre en considération si une extraction dentaire est envisagée.

- **Anamnèse dentaire** = antécédents de soins orientés sur la sphère orale de prise en charge dentaire

Ensuite après avoir interrogé on passe ensuite à **l'examen du patient** :

2. Examen exo-buccal = analyse du patient dans sa globalité

- Analyse de la symétrie du visage
- Tuméfactions
- Palper : pour déterminer si il y a des adénopathies (=état pathologique de la lymphé)
- Analyse des ATM

3. Examen endo-buccal = analyse de la sphère orale (muqueuses, dents, parodonte)

4. Examens complémentaires (radiographies, test au froid, test de percussion, palpation, test de morsures...)

=> Grâce à toutes ces informations + à nos connaissances : **élaboration du diagnostic, qui permettra à son tour d'élaborer le plan de traitement et les propositions thérapeutiques**

C. 2 types de consultations

1. La consultation d'urgence

Elle peut être consécutive à **une séance de soins antérieures**, il faut se demander s'il y'a eu **un soin qui a pu causer des douleurs post-op** (possibles dans le cas de réalisation d'une restauration composite par exemple : le patient peut avoir des douleurs spontanées ou revenir 2 semaines plus tard en disant qu'il a une douleur au froid ou lésion de la pulpe).

On peut également avoir **des complications inflammatoires voire des complications infectieuses** (exemple : suite à traitement endodontique il peut y avoir un épisode de flair-up qui entraîne des grosses douleurs qui sont purement liées à l'acte endodontique en lui-même).

Ensuite, il faut poser le **diagnostic** à partir des éléments présents dans le dossier médical, des traitements réalisés précédemment, des données de l'examen clinique, des examens complémentaires et des doléances (= plaintes) du patient et du recueil de symptomatologie.

Exemple de consultations d'urgences (car ce sont des situations que l'on retrouve très fréquemment) :

- Réalisation d'un soin antérieur très proche de la pulpe (procédure de coiffage pulpaire), le patient revient pour des douleurs pulsatiles, spontanées, insomniantes qui ne cèdent pas aux anti-inflammatoires et antidouleurs. une sensibilité au froid sur la dent concernée et même des douleurs spontanées qui ne se calment pas par prise d'anti-douleur.

=> C'est un cas de Symptomatologie d'une pulpite irréversible

-douleur importante au niveau de la gencive ou dent qui vient d'être soignée.

=> Douleurs consécutives à **la pose du champ opératoire**, dans certains cas la pose du crampon n'est pas forcément très agréable, parfois on doit prendre appui au niveau de la gencive et cela peut créer des douleurs.

- Un patient qui revient après une restauration pour une **surocclusion** sur la dent traitée (la mastication peut générer des douleurs et puis à force d'avoir des contacts sur cette surocculsion il peut avoir une inflammation au niveau desmodontale)

- **Syndrome du septum = bourrage alimentaire** (terme à retenir) dans le cas d'une mauvaise restauration du point de contact qui n'est pas assez fort donc au niveau interdentaire. Il s'agit d'une **inflammation au niveau de la papille dentaire**. Si le point de contact n'est pas assez fort, les aliments peuvent ainsi se coincer en interproximal. Associé à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ce syndrome peut alors apparaître (symptôme d'origine inflammatoire). C'est un syndrome à ne pas négliger et à **ne pas confondre avec une pulpite irréversible**, il peut entraîner d'affreuses douleurs pulsatiles, insomniantes (échelle de douleur parfois de 10/10 pour ce syndrome).

2. La consultation initiale

Recueil d'informations et notamment **les facteurs étiologiques** : (Pour la DRE on aura particulièrement besoin des facteurs étiologiques)

Pourquoi le patient présente des lésions carieuses, lésions érosives, lésions d'usures ? Quels sont les facteurs de risques ? Est-ce qu'ils nécessitent une prise en charge spécifique ?

Il faut contrôler les **facteurs de risque essentiel**, les plus couramment rencontrés sont :

- la carie et l'évaluation du risque carieux individuel : Qu'est-ce qui explique qu'un patient présente des lésions carieuses en bouche ?

Pour évaluer ce risque il faut regarder plusieurs critères :

Alimentation trop sucrée ou trop acide ?

Grignotage ?

Bonne hygiène bucco-dentaire (HBD) ?

Anomalie du flux salivaire en termes de qualité et de quantité ? (certains médicaments peuvent avoir une influence sur cela, notamment les antidépresseurs).

Antécédent de lésions carieuses ? (patient qui en a déjà eu a un risque individuel plus important)

Malpositions dentaires (zone plus difficilement accessible au brossage ou la plaque va plus stagner) ?

NB : Les antidépresseurs peuvent **influencer la quantité de salive en bouche**, or la salive a un rôle de **protection au niveau de la cavité buccale** et en cas de défaut de quantité le risque carieux est augmenté.

Risque érosif : Pour évaluer ce risque il faut regarder plusieurs critères tels que:

- indice BEWE
- Les habitudes alimentaires :
 - La consommation fréquente de boisson acide et surtout les sodas
 - La qualité nutritionnelle des aliments aussi. A contrario les aliments riches en phosphate, calcium vont protéger de ces phénomènes d'érosion.
 - La manière d'ingérer les aliments joue également un rôle, boire à la paille le soda ou le garder en bouche, gargariser les boissons...
- Certaines pathologies comme les RGO (reflux gastro-œsophagien = remontées acides qui créent une acidité majorée dans la cavité buccale).

Troubles de l'alimentation de type boulimie, anorexie où les vomissements vont être à l'origine d'**une augmentation de l'acidité de la cavité buccale et entraîner c'est pertes de substances d'origine érosive.**

Risque associé aux dysfonctions (attrition, bruxisme) :

Pour évaluer ce risque il faut regarder plusieurs critères. Phénomène d'attrition ou autrement dit de bruxisme = grincement des dents avec des forces excessives causant une usure dentaire au niveau des dents antagonistes par contact majoré. On parle de lésions attritionnelles qui sont à surveiller car elles peuvent nécessiter des restaurations.

3. Exemple d'un examen clinique « standard » centré sur la dentisterie restauratrice exclusivement :

- 1) On commence toujours par un Examen exo-buccal : symétries du visage, esthétique, ligne du sourire, type morphologique...
- 2) Examen des ATM : douleurs, degré d'ouverture limité, craquements, déviations de la mâchoire au niveau de l'ouverture et de la fermeture.
- 3) Examen dentaire : formule dentaire (dents manquantes ?) et examen de chaque face/dent
- 4) Examen du parodonte : santé parodontale, support osseux, éventuelles récessions gingivales, indices de plaque et saignements.
- 5) Examen fonctionnel : rapports inter-arcades, classe d'Angle, guidage antérieur, malpositions, plan d'occlusion, calage postérieur, para fonctions, mastication bilatérale ou non...
- 6) Examen du sourire : ligne du sourire, symétrie, teintes et luminosité des dents...

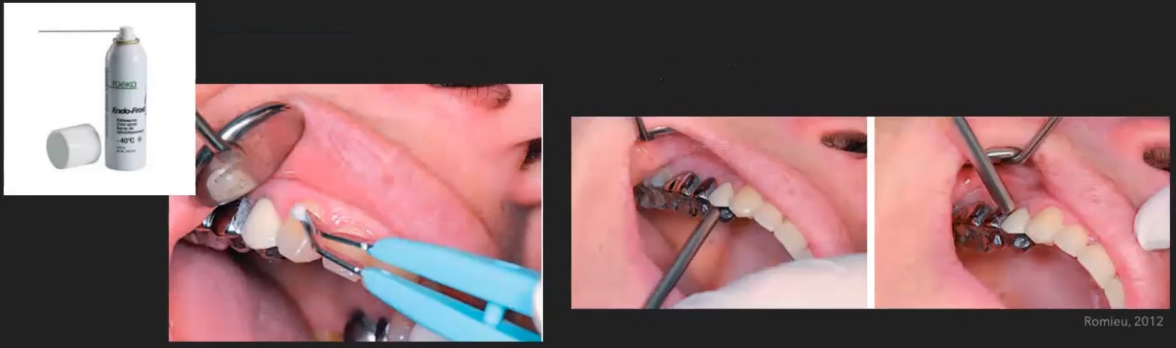
7) Examens complémentaires :

Examens complémentaires:

Tests de sensibilité au froid : généralement effectué avec des petites boulettes de coton. On place sur la dent une boule de coton imbibée de froid par un spray de tétrafluoroéthane, cela agit comme un petit glaçon qu'on vient poser sur la dent pour vérifier si celle-ci répond positivement au froid et qui évalue la sensibilité nerveuse et donc **l'innervation** (et non la vascularisation de la dent !!). (sur la diapo à gauche)

CONSULTATION & DIAGNOSTIC EN DENTISTERIE RESTAURATRICE - ENDODONTIE

EXAMEN CLINIQUE « STANDARD » CENTRÉ SUR LA DENTISTERIE RESTAURATRICE



tests de sensibilité au froid
(spray tétrafluoroéthane)

tests percussion
axiale et latérale

Romieu, 2012

Tests de sensibilité électrique : On place une petite électrode sur la dent qui libère une intensité électrique qui augmente au fur et à mesure. Lorsque le patient ressent l'impulsion électrique c'est à dire une sorte de petit picotement il lève la main et pour que le dentiste relève le chiffre associé à son degré de sensibilité.

Tests de sensibilité par percussion : Percussion axiale et latérale pour voir si le patient ressent une douleur (se fait par manche d'instrument métallique : on tapote en axiale et en latérale). (sur la diapo à droite)

Tests de sensibilité par palpation : On passe le doigt au niveau de la muqueuse (apex de la dent) et on voit si le patient ressent des douleurs à la palpation, notamment pour diagnostiquer des pathologies péri-apicales.

Tests de sensibilité par morsure : On fait mordre le patient sur un instrument, en général sur un instrument en plastique et on voit s'il ressent une douleur à la pression ou au relâchement. Cela sert à diagnostiquer d'éventuelles fêlures ou fractures.

Les tests présentés ci-dessus sont vraiment à retenir dans un premier temps. Après il en existe pleins d'autres.

Autres examens complémentaires :

Examens fonctionnels : Au niveau de l'occlusion (on ne s'attardera pas dessus en DRE)

Tests salivaires : On verra ça en parodontologie pour faire des tests bactériens, des tests d'acidité notamment pour avoir une idée du risque érosif.

Radiographies : Rétro-alvéolaires, panoramiques, CBCT

Photographies : Exo-buccale ou endo-buccale

Tests de phonation

Moulages : Empreintes conventionnelles ou optiques

Montage en articulateur

Pour conclure, une fois que l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires sont réalisés, il faut aboutir à un diagnostic. C'est ce diagnostic qui vous guidera vers la ou les différentes options thérapeutiques.

La notion de consentement éclairé est ici extrêmement importante afin que le patient soit informé de tout ce qui concerne son cas, son diagnostic, son plan de traitement, tous les traitements thérapeutiques qui lui sont proposés. Cela permet de vérifier l'adhésion du patient à ce qui lui a été proposé : c'est une forme de gage de motivation et d'engagement à suivre le traitement s'il a recueilli toutes les informations. Cela peut limiter des abandons de soins.

Sans oublier de bien remplir le dossier médical en hiérarchisant les différentes étapes du plan de traitement.

II. LE DIAGNOSTIC

Notes de la professeure : Être capable donc de s'entraîner à savoir remplir les tableaux (remplir avec + ou - aux différentes pathologies) ou à poser un diagnostic à partir d'un tableau déjà complété.

Il faut savoir que la situation clinique et les symptômes décrits par le patient sont souvent différents de l'histologie et de ce qu'il se passe réellement au niveau de la dent. C'est pourquoi souvent on est amené à faire des écarts de diagnostic car les symptômes peuvent être variables selon les patients. Le diagnostic va être établi par vos connaissances en termes de physiopathologie pulpaire, de l'interrogatoire de votre patient, des différents tests cliniques et des examens complémentaires que vous mènerez.

A. Les pathologies pulpaires

Rappel sur la physiologie pulpaire :

La pulpe saine est un **tissu conjonctif qui est innervé et vascularisé**. (il existe maintenant des moyens de test de l'innervation qui permettent de se rendre compte de l'état de conservation de la pulpe et de son innervation afin de savoir si la dent est toujours vitale).

La dentine et la pulpe constituent **une seule et même entité : le complexe pulpo-dentinaire**. Pulpe et dentine : c'est une seule et même entité donc tout ce qui va avoir des répercussions au niveau de votre dentine va générer des effets sur le tissu pulpaire et inversement.

Il faut retenir que la cause majeure d'inflammation et d'infection de l'organe dentaire est d'origine **bactérienne**.

Même s'il existe des inflammations pulpaires générées par d'autres facteurs tels que des facteurs chimiques ou physiques (effet iatrogène de l'instrumentation (par exemple échauffement de la dent et de la pulpe inflammation en absence de refroidisseur), usure, orthodontie (mouvements dentaires peuvent générer des inflammations)...))

Dans tous les cas, lorsqu'un de ces facteurs est présent, il va y avoir soit des toxines soit des enzymes bactériennes ou encore des produits de dégradation de la matrice dentinaire (des cellules et de la matrice). Ces derniers vont glisser vers la pulpe. Ce qui va conduire à des réponses immunitaires et inflammatoires engendrant des répercussions au niveau cellulaire, vasculaire et nerveux.

Si on prend les différents diagnostics dentaires possibles, on va commencer par faire le même déroulé d'examen (À bien retenir) :

- Interrogatoire
- Examen clinique
- Examen complémentaire (Test sensibilité ; Test percussion ; Test palpation = ces 3 tests sont ceux de base + on ajoute l'examen radiographique si nécessaire)
- Diagnostic

(Test sensibilité = ressentir le froid/chaud ; Test percussion et palpation = douleur lors du test)

1. Pulpite réversible (suivre l'image en bas)

Appelée aussi « Hyperhémie pulpaire », « pulpite subaiguë » ou « pré-pulpite ». Comment elle se manifeste?

Généralement c'est un patient qui va venir vous voir pour **des douleurs aiguës provoquées par le froid ou le sucrée**, en mangeant des bonbons ou buvant de l'eau froide il va donc avoir des douleurs provoquées et non spontanées. Elles disparaissent peu de temps après arrêt du stimulus (c'est-à-dire qu'une fois que le patient a bu son eau froide, la douleur n'est plus présente).

Anamnèse : douleurs aiguës, provoquées, non spontanées, disparaissant peu de temps après arrêt du stimulus.

On va donc commencer par :

1- Examen exo-buccal : normal (donc absence adénopathie, de tuméfaction, d'asymétrie particulière)

2-Examen endo-buccal (= ce qui se passe en bouche) : observation de toutes les dents, ensuite on localise notre examen clinique au niveau de la zone douloureuse mise en évidence de la présence d'une étiologie qui pourrait être responsable des douleurs du patient: lésion carieuse, fêlure, fracture, restauration non hermétique, ...

Ensuite on passe aux examens complémentaires :

SENSIBILITÉ : **positif(+)**, **PERCUSSION** : **négatif(-)**, **PALPATION** : **négatif(-)**.

Test sensibilité : positif car la pulpe va toujours être vitale, donc lorsqu'on effectue un test de sensibilité au froid, le test sera positif.

Test percussion (Mise en évidence d'une **inflammation du desmodonte**) : négatif, on tape avec notre manche métallique au niveau axial ou latéral, le patient n'a aucune douleur particulière, donc absence de douleur. On peut comparer avec les dents adjacentes pour vérifier que la réponse est normale.

Test palpation (Mise en évidence d'une **éventuelle pathologie péri apicale**) : négatif, palpation avec le doigt au niveau du vestibule en regard des apex, donc absence de douleur.

Examen radiographique : éventuelle lésion carieuse, fracture, ou un soin conservateur / un composite non hermétique où on peut voir une radio clarté sous la restauration, signe d'une éventuelle récurrence carieuse. Pas d'image radio-claire au niveau péri-apical, car pas d'inflammation suffisamment importante, donc pas d'images de lyse osseuse.

Bilan : seulement manifestation : douleur provoquée qui disparaît à la fin de la stimulation.

Diagnostic : Pulpite réversible (fréquemment posé).

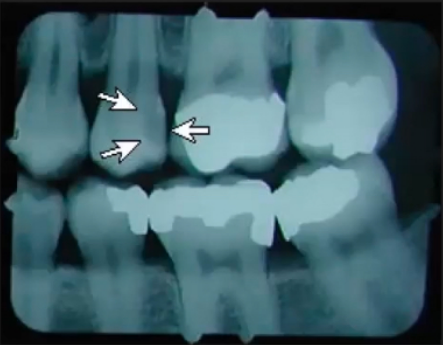
Radiographie rétrocoronaire (on voit seulement les dents des arcades antagonistes uniquement au niveau des couronnes : absence des apex)

o Radio Rétro Coronaire = radio de choix pour visualiser les caries interproximales.

Ici on voit les secteurs 2 et 3, et on voit une lésion carieuse au niveau distal de la 25.

PULPITE RÉVERSIBLE
« Hyperhémie pulpaire », « pulpite subaiguë » ou « pré-pulpite »

INT.	DOULEUR PROVOQUÉE
EXAM.	carie/obturation/fêlure/...
SENS.	+
PERC.	-
PALP.	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale Carie / obturation
DIAG.	PULPITE REVERSIBLE



2. Pulpite irréversible symptomatique(voir image en bas)

Anamnèse :

Patient avec **des douleurs aiguës** (douleur à 8 sur 10), spontanées, référées, pulsatiles, pouvant être insomniantes. **Les douleurs ne cèdent pas aux antalgiques** : résistantes aux antalgiques palier 1. La douleur se déclenche de manière inopinée en journée, empêche le patient de dormir. Cette douleur va être exacerbée **par stimulations thermiques** (le patient ne peut même plus boire de l'eau un peu froide), **par certaines activités physiques** (dû à un afflux vasculaire qui va être plus important) ou **des modifications posturales** (position couchée ou flexion dans lesquelles le patient ressent plus de douleurs).

Examen exo-buccal : normal (pas de manifestations externes à noter)

Examen endo-buccal : présence d'une étiologie (lésion carieuse, fêlure, fracture, restauration non hermétique).

Test SENSIBILITÉ : positif . Pulpe toujours vitale mais dans état d'inflammation tel que lorsqu'on fait le test au froid on a douleur exacerbée avec persistance de la douleur >30sec,

Test PERCUSSION : négatif (pas de douleur exacerbée sauf dans certains de figure si il y a inflammation du desmodonte si pulpo- desmodontite),

Test PALPATION : toujours négatif

Examen radiographique : au niveau coronaire : éventuelle lésion carieuse profonde, éventuelle fracture, éventuelle récidence carieuse sous une restauration. Pas d'image radio claire au niveau péri-apical.

Diagnostic : pulpite irréversible symptomatique (fréquemment posé).

Les deux premiers cas sont des cas très fréquents donc à **maîtriser**.

Radiographie rétro alvéolaire (on devrait voir les apex en entier) : On voit une énorme lésion carieuse d'une dent du secteur 3, où on voit notre 36 et puis la dent adjacente qui est la 37 avec une grosse restauration. Lésion carieuse au niveau distal, cette lésion atteint la zone juxta-pulpaire voire même la pulpe. C'est donc dans ce de cas qu'on voit des patients avec des pulpites irréversibles symptomatiques.

INT.

EXAM.

SENS.

PERC.

PALP.

RADIO

DIAG.

DOULEUR SPONTANÉE

carie/obturation/
fêlure/...

+

(exacerbé)

-

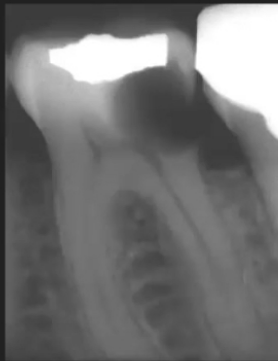
(sauf si desmodonte +)

-

Absence d'image
radio-claire
péri-apicale
Carie / obturation

PULPITE
IRREVERSIBLE
SYMPTOMATIQUE

PULPITE IRREVERSIBLE SYMPTOMATIQUE



3. Pulpite hyperplasique

Ici on a un diagnostic qui est beaucoup plus rare, mais qui est très facile à poser.

Anamnèse : symptomatologie et douleurs réduites voire inexistantes, souvent chez patient

jeune(enfants ou adolescents) (dents temporaires ou dents permanentes immatures)

Examen exo-buccal : normal

Examen endo-buccal : présence d'un polype pulpaire qui recouvre quasiment totalement la dent qui va alors être peu sensible aux stimulations thermiques

SENSIBILITÉ : positif souvent atténuée voire absente,

PERCUSSION : négatif,

PALPATION : négatif

Examen radiographique : Hormis la perte de substance coronaire liée à lésion carieuse et où est présent ce polype pulpaire, on n'aura pas d'image radio-claire au niveau péri-apical.

Diagnostic : Cette pulpite hyperplasique fait partie des pulpites irréversibles, parce que l'atteinte pulpaire est irréversible, on ne pourra pas conserver la vitalité de la pulpe, mais elle est asymptomatique.

INT.	ABSENTE
EXAM.	Polype pulpaire
SENS.	 (atténué)
PERC.	
PALP.	
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale Caries
DIAG.	PULPITE IRREVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE Pulpite hyperplasique



4: Dégénérescence calcique

Ceci est très fréquent et fait partie elle aussi **des pulpites irréversibles asymptomatiques**.

Anamnèse : aucun symptôme

Examen exo-buccal : normal

Examen endo-buccal : Éventuelle dyschromie de la dent (couleur jaunâtre)

SENSIBILITÉ : positif (en cas de dégénérescence calcique partielle : positif mais atténué) en cas de dégénérescence calcique complète : négatif

PERCUSSION : négatif

PALPATION : négatif (test de cavitation +)

Examen radiographique : Réduction du volume pulpaire. Disparition de la chambre pulpaire et des canaux. Présence de pulpolithes/minéralisations diffuses, pas d'image radio-claire ai niveau péri apical.

On peut voir cette dyschromie de couleur jaunâtre, opacité accentuée sur la 21. Sur l'examen radiographique, on a une calcification complète du système endo canalaire, une disparition complète de la pulpe au niveau de la 21.

INT.	ABSENTE
EXAM.	Eventuelle dyschromie
SENS.	+ (atténué voire négatif)
PERC.	-
PALP.	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale Volume pulpe réduit
DIAG.	PULPITE IRREVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE Dégénérescence calcique



5: Résorption interne (parmis les phénomènes de pulpites irréversibles asymptomatiques)

Anamnèse : aucun symptôme ou parfois douleurs peu durables ou peu intenses, lorsque résorption perforante

Examen exo-buccal : normal

Examen endo-buccal : Éventuelle dyschromie au coronaire si résorption (« pink spot » car vraiment point rose,

SENSIBILITÉ : positif et peut être atténuée

PERCUSSION : négatif,

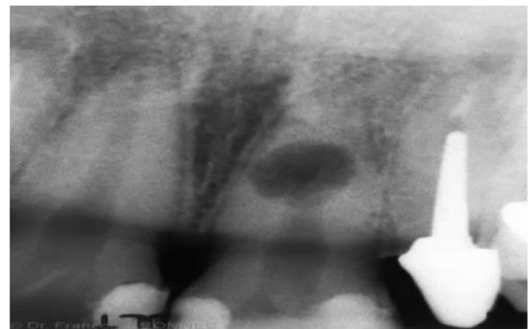
PALPATION : négatif

Examen radiographique : résorption centrée sur le canal (intérêt CBCT ++).

Diagnostic : Pulpite irréversible asymptomatique, phénomène de résorption interne

INT.	ABSENTE
EXAM.	Eventuelle dyschromie (pink spot)
SENS.	+
PERC.	-
PALP.	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale
DIAG.	Résorption PULPITE IRREVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE Résorption

C'est une radiographie rétro alvéolaire où on voit bien l'apex de la dent, on y retrouve une lésion radio-claire. On à gauche notre 11 et à droite notre 21, qui cette dernière présente la résorption centrée sur le canal. Et tout à droite complètement, on a la 22 qui présente un inlay core avec un ancrage radiculaire avec probablement une couronne par dessus.



6. Nécrose pulpaire

Anamnèse : aucune douleur, dyschromie grisâtre au niveau de la dent rechercher éventuels antécédents de traumatismes

Examen exo-buccal : normal

Examen endo-buccal : Dyschromie /Perte de translucidité (opacité/ dyschromie grisâtre) mais rien d'autre

SENSIBILITÉ : négatif,

PERCUSSION : négatif,

PALPATION : négatif

Examen radiographique : pas d'image particulière à la radio-claire péri- apical.

Nécrose pulpaire peut vraiment s'évaluer à la présence d'une dyschromie et d'un test au froid négatif.

INT.	ABSENTE
EXAM.	Eventuelle dyschromie
SENS.	-
PERC.	-
PALP.	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale
DIAG.	NECROSE PULPAIRE

Tableau récapitulatif des pathologies pulpaire

INT.	DOULEUR PROVOQUÉE	DOULEUR SPONTANÉE	ABSENTE			
EXAM.	carie/obturation/fêlure/...	carie/obturation/fêlure/...	Polype pulpaire	Eventuelle dyschromie	Eventuelle dyschromie (pink spot)	Eventuelle dyschromie
SENS.	+	+ (exacerbé)	+ (atténué)	+ (atténué voire négatif)	+ (atténué)	-
PERC.	-	- (sauf si desmodonte +)	-	-	-	-
PALP.	-	-	-	-	-	-
RADIO	Absence d'image radio-claire péri-apicale Carie / obturation	Absence d'image radio-claire péri-apicale Carie / obturation	Absence d'image radio-claire péri-apicale Carie	Absence d'image radio-claire péri-apicale Volume pulpe réduit	Absence d'image radio-claire péri-apicale Résorption	Absence d'image radio-claire péri-apicale
DIAG.	PULPITE REVERSIBLE	PULPITE IRREVERSIBLE SYMPTOMATIQUE	PULPITE IRREVERSIBLE ASYMPTOMATIQUE Pulpite hyperplasique	Dégénérescence calcique	Résorption interne	NECROSE PULPAIRE

B- Pathologies péri-apicales

Appelée aussi parodontite apicale = réactions de défense de l'organisme à l'infection de l'endodonte (c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux / une réaction immunitaire qui se passe au niveau péri-apical) => confinement des bactéries au niveau de l'endodonte afin d'éviter leur propagation dans les tissus environnants.

—> Résorption osseuse = lyse osseuse (détectable à la radio : on parle de zone radio claire péri-apicale , qui est un effet secondaire du processus inflammatoire)

En résumé :

- 1ère étape : le processus inflammatoire qui vise à contrer la réaction inflammatoire de l'endodonte

- 2ème étape : si le processus inflammatoire est maintenu alors on aura résorption osseuse détectable radiographiquement car c'est une zone radioclaire.

L'ensemble de des réactions immunitaires aboutit à la formation d'une **Lésion**

Inflammatoire Péri-radriculaire d'Origine Endodontique (LIPOE) (on en parle dès qu'on a une zone radio claire).

Ensuite, tout ce qui va être interrogatoire, examens cliniques, ça sera exactement la même chose que pour les pathologies pulpaire. La seule différence c'est que dans les pathologies péri-apicales, on pourra observer un œdème au niveau des tissus mous et la présence éventuelle d'une fistule dans certains cas.

1. Conditions péri-apicale « normales »

Eléments essentiels à retenir lors d'un examen clinique normal sur une dent saine:

- Examen clinique : Silence clinique, absence de douleur
- Test de sensibilité : positif
- Tests de percussion et palpation : négatif
- Pas d'œdème, ni de fistule, ni tuméfaction
- Sondage parodontal normal
- Radiographie : lamina dura régulière, espace ligamentaire de largeur normale. On retrouve bien une continuité au niveau des apex de l'espace ligamentaire, de l'os, de la lamina dura, une zone un peu plus dense en périphérie. Et l'absence d'image radio claire péri-apicale, on n'a pas de lyse osseuse. C'est donc les conditions de dents saines.

INT.	Ø DLR
SENS.	+
PERC.	-
PALP.	-
OED.	-
FIS.	-
RADIO	-
DIAG.	Dent saine



2. Parodontite apicale symptomatique ou aiguë (PAA)

Eléments essentiels à retenir :

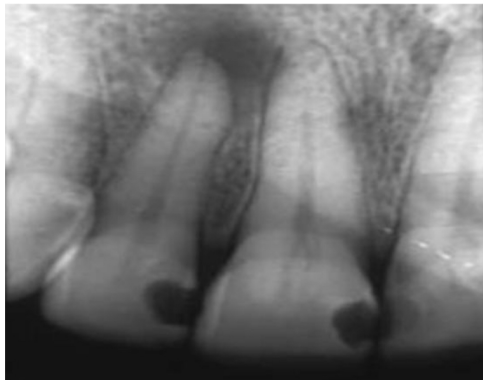
- **PAA « primaire »** (infection de la pulpe dans une région péri apicale précédemment saine) ou **PAA « secondaire »** (dent ayant déjà présenté une PAC ==> Parodontite apicale chronique qui se réactive et devient PAA et donne douleurs)
- Douleurs intenses, spontanées, rémanentes
- **Test sensibilité** : négatif car souvent la dent sera nécrosée, peut être positif en cas de lésion débutante
- **Test percussion** : positif douleur +++
- **Test palpation** : négatif (pas d'œdème, de fistule ou d'exteriorisation de pus)
- Sensation de « dent longue », le patient a l'impression que **sa dent est plus longue de d'habitude** et c'est lié à cet **épaississement ligamentaire** qui va entraîner une suroccclusion au niveau de la dent. C'est extrêmement douloureux.
- Radiographie : peut être associée à une radio clarté (LIPOE)

INT.	SPONTANÉE
	PROVOQUÉE
SENS.	-
PERC.	+
PALP.	-
OED.	-
FIS.	-
RADIO	+ -
DIAG.	PAA

3. Parodontite apicale asymptomatique/chronique

Éléments essentiels à retenir :

- Issu d'un processus inflammatoire péri-apical ancien (exemple : une PAA qui est devenue chronique) aucun signe ni symptôme clinique et tous les tests seront négatifs
- Tests SENS, PERC, PALP : négatifs : résorption osseuse = Lyse osseuse péri-apicale : seule chose visible
- Elle est fréquemment découverte de manière fortuite (c'est-à-dire lors d'une radiographie de contrôle parce qu'on a un doute sur une dent). Sur cette radiographie rétro-alvéolaire, on peut voir la 11 et la 12 qui présentent des soins qui ne sont pas radios opaques. Les zones radio claires ressemblent à des restaurations qui ne sont pas radios opaques, puisqu'à une époque, les matériaux n'avaient pas de radio opacifiant, ce qui donne cet aspect-là. On peut voir aussi à l'apex de la 12, une lyse osseuse péri-apicale qui correspond à un processus inflammatoire.



INT.	Ø DLR
SENS.	—
PERC.	—
PALP.	—
OED.	—
FIS.	—
RADIO	+
DIAG.	PAC

4. Ostéite condensante (examen plus rare)

Éléments essentiels à retenir :

-Diagnostic beaucoup plus rare, mais simple à poser, et qui ne pose pas de problématique particulière

-Parodontite apicale asymptomatique avec image radio opaque unique, homogène, arrondie

-Réaction osseuse fait suite à un stimulus inflammatoire de faible intensité, généralement observé à l'apex des dents postérieures (molaires ou prémolaires) ou au niveau du site d'extraction.

Test sensibilité : la dent peut être + ou – au test au froid

Sinon : pas de douleurs

C'est un diagnostic facile à poser.

Au niveau de l'apex de la dent, on peut avoir une augmentation de la radio opacité de l'os. Os beaucoup plus dense au niveau de l'apex.

Diagnostic simple à poser qui se base sur la radiographie.

INT.	Ø DLR
SENS.	+ -
PERC.	-
PALP.	-
OED.	-
FIS.	-
RADIO	Image radio-opaque
DIAG.	Ostéite condensante

5. Abscès apical aigu (AAA)

Éléments essentiels à retenir :

C'est une urgence très fréquente.

-Apparition rapide, douleur spontanée et permanente intense : souvent le patient ne dort plus

Test SENSIBILITÉ : négatif car la dent est nécrosée ou déjà traitée endodontiquement ;

Test PERCUSSION : positif +++ : énorme douleur à la pression et à la mastication ;

Test PALPATION : positif (présence d'un œdème)

-Douleurs à la pression (contact occlusal +++), œdème fréquent

INT.	SPONTANÉE
SENS.	-
PERC.	+
PALP.	+
OED.	+ -
FIS.	-
RADIO	+ -
DIAG.	AAA

= formation de pus au niveau du périoste et tuméfaction. Pas d'extériorisation du pus donc pas de soulagement . Absence de fistules.

-Destruction de la table osseuse, accumulation de pus sous le périoste donc cet abcès est aigu car il y a une absence de fistule (seule l'extériorisation permettra l'atténuation des douleurs)

- LIPOE fréquemment retrouvée, mais pas systématique.

- Radiographie : Parfois image radio claire mais pas systématique.

Rougeur au niveau de dents qui sont couronnées. A priori on a la 24 qui est couronnée avec cette rougeur au niveau de la gencive en regard de la zone apicale. Lorsqu'on va effectuer notre percussion/palpation, on va avoir une douleur ressentie. Ici on n'a pas d'œdème, seulement une rougeur mais qui elle va se transformer en œdème avec l'accumulation de pus au niveau péri apical.



6. Abcès apical chronique

Éléments essentiels à retenir :

-Absence de symptomatologie car cette fois le pus a pu s'extérioriser. Il y a donc une fistule qui correspond au trajet de sortie du pus.

Signe caractéristique : fistule ancienne

-Perforation de l'une des tables osseuses => chemin fistuleux permettant la libération continue du pus vers la muqueuse buccale (ou autres sites par lequel le pus peut s'extraire : cutané, ligament parodontal, zone de furcation, cavités nasales et sinus maxillaire)

Pas de douleurs mais présence de fistule.

-Sensibilité : négatif car la dent est nécrosée ou déjà traitée endodontiquement

PERCUSSION : négatif

PALPATION : négatif

-Absence d'œdème

INT.	Ø DLR
SENS.	-
PERC.	-
PALP.	-
OED.	-
FIS.	+
RADIO	+
DIAG.	AAC

-Asymptomatique ou légèrement symptomatique car l'os et le périoste sont déjà perforés

Radiographie : Associé à zone de clarté.

Radiographie rétro alvéolaire, dent qui avait commencé à être traitée, on le voit au niveau de la chambre pulpaire avec un matériau d'obturation provisoire. Et au niveau péri apical, on voit une grosse lésion péri apicale, une grosse LIPOE qui peut être à l'origine d'une AAC.



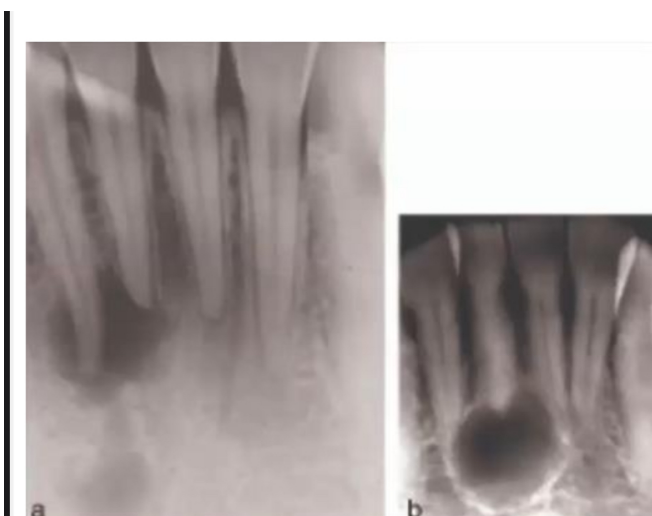
7. Kyste péri-apical

Éléments essentiels à retenir :

- Le kyste péri-apical est l'évolution d'un granulome inflammatoire péri-apical
- Cavité bordée par un épithélium
- Peut conduire à des pertes osseuses volumineuses
- Asymptomatique, découverte fortuite à la radiographie panoramique

INT.	B DLR
SENS.	-
PERC.	-
PALP.	-
OED.	-
FIS.	-
RADIO	+
DIAG.	Granulome/ Kyste

Pas de symptômes particuliers : le plus souvent c'est une découverte fortuite lorsque l'on fait une panoramique : on s'aperçoit de la lyse osseuse. (tous les tests négatifs).



A gauche : granulome : lyse osseuse avec zone très peu définie.

A droite : le kyste avec épithélium qui délimite très bien la zone.

8 . Cellulite

Éléments essentiels à retenir :

- Facile à diagnostiquer d'un point de vue exo buccal
- Infection des tissus cellulaires de la face et du cou (plans fasciaux situés entre les muscles du visage et du cou)
- Tuméfaction diffuse des tissus du visage, souvent la conséquence d'un abcès apical sans propagation de pus
- Peut être associée à des symptômes systémiques (fièvre, malaise)
- Mêmes signes cliniques que l'AAA :
- Test SENSI : négatif car nécrose ou dent déjà traitée

Test PERCU et PALPA : +++

Gros œdème et pas de trajet fistulaire

-Très très important à prendre en charge car peuvent être à l'origine de complications graves voire mortelles car c'est une dissémination de bactéries dans tout l'organisme.

INT.	SPONTANÉE
SENS.	-
PERC.	+
PALP.	+
OED.	+
FIS.	-
RADIO	+
DIAG.	Cellulite

INT.	Ø DLR	SPONTANÉE PROVOQUÉE	Ø DLR	Ø DLR	Ø DLR	SPONTANÉE	Ø DLR	Ø DLR	SPONTANÉE
SENS.	+	-	-	+ -	-	-	-	-	-
PERC.	-	+	-	-	+	-	-	+	+
PALP.	-	-	-	-	+	-	-	+	+
OED.	-	-	-	-	+ -	-	-	+	+
FIS.	-	-	-	-	-	+	-	-	-
RADIO	-	+ -	+	Image radio-opaque	+ -	+	+	+	+
DIAG.	Dent saine	PAA	PAC	Ostéite condensante	AAA	AAC	Granulome/ Kyste	Cellulite	

Tableau récapitulatif des pathologies péri-apicales

